

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

MBA · MEDIDA DE PERCEPCIÓN DEL CUERPO

Measure of Body Apperception – Autoinforme de evaluación de la imagen corporal, atractivo y adaptación post-quirúrgica en patología médica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Measure of Body Apperception (MBA / Medida de Apreciación del Cuerpo)
Autores Originales	Charles S. Carver, C. Pozo-Kaderman, A. A. Price, V. Noriega, S. D. Harris et al. (1998)
Procedencia y Ámbito	University of Miami (EE. UU.) y servicios de psicooncología quirúrgica
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico dimensional breve
Población Diana	Pacientes adultos intervenidos de cirugía modificadora del cuerpo (mastectomía, ostomías, reconstrucción mamaria, cirugía oncológica)
Tiempo de Aplicación	3 a 5 minutos (10 reactivos estructurados)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert de 5 puntos: 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo)
Finalidad Clínica	Cuantificación del malestar con la imagen corporal postquirúrgica, autopercepción de atractivo sexual y adaptación psicosocial a secuelas físicas

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Las intervenciones quirúrgicas oncológicas mayores —muy especialmente las cirugías por cáncer de mama (mastectomía radical o tumorectomía conservadora)— inducen con frecuencia una alteración profunda de la autoimagen corporal que repercute directamente en la autoestima, la vivencia de feminidad y la vida sexual de la paciente. Las escalas clásicas de trastornos alimentarios (como el EDI o el BSQ) están orientadas al impulso de delgadez y la fobia a las calorías, resultando inadecuadas para medir el impacto de cicatrices o deformidades quirúrgicas reales.

El equipo de Charles S. Carver en la Universidad de Miami formuló la MBA como un instrumento focalizado en la vivencia afectivo-cognitiva que la paciente experimenta respecto a su propio cuerpo modificado por la enfermedad. El modelo bifactorial subyacente distingue: a) **Sentimientos de Atractivo e Integridad Corporal**, que exploran sentirse sexualmente atractiva, satisfecha con la apariencia y cómoda ante la propia desnudez; y b) **Malestar / Deformidad Percibida**, que evalúa la vivencia de mutilación, la vergüenza ante la pareja y la necesidad de ocultar las cicatrices físicas.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Factor Clínico	Nº Ítems	Contenido Clínico y Manifestaciones Evaluadas
Atractivo y Aceptación	5 ítems	Sentirse físicamente atractiva, satisfecha con el propio cuerpo, femenina, cómoda mirándose al espejo y segura al vestirse.
Malestar e Inseguridad	5 ítems	Sentirse mutilada o incompleta, temor al rechazo sexual de la pareja, vergüenza ante la desnudez y disgusto al ver las cicatrices.
Puntuación Total MBA	10 ítems	Rango: 10 a 50 puntos (índice dimensional de adaptación a la imagen corporal).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · MBA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.85 a 0.89 en estudios psicooncológicos internacionales y en adaptaciones hispanas en cáncer de mama (Carver et al., 1998).
Fiabilidad Test-Retest	Coeficiente de correlación intraclase $r = 0.82$ tras intervalo de 3 a 4 semanas en pacientes postquirúrgicas estables.
Validez Discriminante	Diferencia con gran significación ($p < 0.001$) entre mujeres sometidas a tumorectomía conservadora frente a mastectomía radical sin reconstrucción.
Validez Concurrente	Correlación negativa significativa con depresión (BDI-II, $r = -0.58$), correlación positiva con autoestima de Rosenberg ($r = 0.64$) y con calidad de vida sexual (FSFI, $r = 0.59$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- Escala de Calificación:** Cada uno de los 10 reactivos se califica de 1 a 5:
 - 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral / No estoy segura; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.
- Inversión de Ítems:** Los 5 ítems de Malestar/Deformidad se invierten (o se codifican en sentido inverso: 5=1, 4=2, 3=3, 2=4, 1=5) para que puntuaciones más altas reflejen consistentemente **mayor satisfacción y adaptación corporal positiva**.
- Puntuación Total:** Suma de las puntuaciones corregidas de los 10 reactivos.
- Rango de Puntuación:** De 10 a 50 puntos totales.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación MBA	Nivel de Adaptación	Imagen Corporal	Directriz Asistencial Recomendada
41 a 50 puntos	Excelente Adaptación	Positiva / Saludable	Integración armónica de los cambios físicos. Seguimiento.
31 a 40 puntos	Adaptación Favorable	Adecuada	Aceptación razonable con dudas menores en intimidad.
21 a 30 puntos	Malestar Moderado	Insatisfacción Clara	Indicación de apoyo psicooncológico y terapia de pareja.
10 a 20 puntos	Severo Rechazo Corporal	Dismorfia / Trauma	Intervención psicológica intensiva; valorar reconstrucción.

ALERTA DE DESADAPTACIÓN POSTQUIRÚRGICA (MBA $\leq$ 25): Puntuaciones de 25 o inferiores reflejan un rechazo visceral a la cicatriz y a la apariencia física modificada, asociándose en más del 70% de los casos a disfunción sexual secundaria (anorgasmia, anhedonia sexual) y aislamiento conyugal.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · MBA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Administración a los 3 y 6 meses Postcirugía: Aplicar en revisiones oncológicas o reconstructivas.

Paso 2: Conducta Terapéutica Asistencial:

- **Si MBA > 30:** Adaptación corporal positiva. Reforzar el autocuidado y normalización de la actividad social.
- **Si MBA ≤ 30:**
 1. Explorar si el malestar radica en evitación del espejo o vergüenza en la intimidad con la pareja.
 2. Iniciar terapia cognitivo-conductual centrada en imagen corporal: exposición guiada al espejo sin censura, resignificación de cicatrices como signos de supervivencia y comunicación asertiva sexual.
 3. Si la paciente presenta mastectomía no reconstruida con MBA < 20, derivar a cirugía plástica para información objetiva sobre opciones de reconstrucción mamaria diferida.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 46 años, profesora de primaria, intervenida de mastectomía unilateral izquierda por carcinoma ductal infiltrante hace 5 meses, remitida por su oncólogo a psicooncología por llanto continuo al vestirse y cese total de relaciones íntimas con su esposo.

Evaluación Psicométrica Inicial en MBA: Total = 18 / 50 puntos (Severo Rechazo Corporal).

- Puntuaciones mínimas en Atractivo (1/5): afirma sentirse completamente mutilada, deforme y desprovista de feminidad.
- Puntuaciones máximas en Malestar (5/5): se niega a desnudarse con la luz encendida, se baña cubriéndose la zona operada y evita mirarse al espejo desde la intervención.

Intervención Psicológica: Se diseñó un programa estructurado de 10 sesiones de intervención en imagen corporal. Se aplicó desensibilización sistemática con exposición en vivo al espejo de forma gradual (mirar la zona vestida, en penumbra y finalmente con luz normal), combinada con reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos de inutilidad estética y sesiones conjuntas con su marido para abordar el miedo mutuo al rechazo táctil. En la reevaluación a los 4 meses, la puntuación MBA ascendió a 36 puntos, reanudando la paciente la vida íntima y manifestando una aceptación serena de su cuerpo.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CLÍNICAS

- Puntuaciones inferiores a 20 con afectación del humor deben alertar de un Trastorno Adaptativo con Depresión Mayor o ideación suicida encubierta.
- La desadaptación corporal grave se asocia a abandono de tratamientos adyuvantes hormonales (tamoxifeno, inhibidores de aromatasa).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Trastorno Dismórfico Corporal Primario:** Defecto imaginado o mínimo preexistente sin intervención quirúrgica oncológica causal.
- **Trastornos de la Conducta Alimentaria:** Descontento corporal ligado a la fobia al peso y masa grasa, ausente en la problemática médica de la MBA.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Carver, C. S., Pozo-Kaderman, C., Price, A. A., Noriega, V., Harris, S. D., Derhagopian, R. P., Robinson, D. S., & Moffatt, F. L. Jr. (1998). Concern about aspects of body image and adjustment to early stage breast cancer. *Psychosomatic Medicine*, 60(2), 168–174.
- Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (Eds.). (2002). *Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice*. Guilford Press.
- Hopwood, P., Fletcher, I., Lee, A., & Al Ghazal, S. (2001). A body image scale for use with cancer patients. *European Journal of Cancer*, 37(2), 189–197.
- Fobair, P., Stewart, S. L., Chang, S., D'Onofrio, C., Banks, P. J., & Bloom, J. R. (2006). Body image and sexual problems in young women with breast cancer. *Psycho-Oncology*, 15(7), 579–594.